



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN GERIATRI
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
Nomor : 001.3/I-PDM/DIR/I/2026

Tentang
Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri

Penanggung Jawab :



dr. Heriyatmo,Sp. PD

Disetujui Oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kep.,AFP

Ditetapkan Oleh :
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakannya Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 01 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN

PENGARAH : Dr.dr. Aslichah

PENYUSUN :

1. dr. Heriyatmo, Sp. PD
2. dr. Amanda Firmandani
3. dr. Moch Safri Darmaputra
4. Ns. Isa Ariyanti, S.Kep
5. Ns. Risma Indra Setiyani, S.Kep
6. Billy Mavino Perkasa, Amd.Kep
7. Devi Kartika Sari, Amd.Kep
8. Ns. Saudah, S.Kep
9. Fatimatuzzahro, Amd.Kep
10. Yayuk Rinika, Amd.Kep
11. Ns. Ani Dwi Karima, S.Kep
12. Ns. Dewi Eka Yanti, S.Kep
13. Fifi Wahyuningsih, Amd. Keb
14. Ns. Annisa Fitri, S.Kep
15. Saghita Puspitasari, Amd. Kep
16. Diryati Barin Putri, S.Farm., Apt
17. Eka Firda Ristia Putri Suryanto, Amd. Gz
18. Dinar Sahara, Amd.Fis
19. Mokhammad Eriko Firdaus, S.Kom
20. Hury Markustinus, Amd.RMIK., S.MIK

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

TM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

PERATURAN DIREKTUR..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

BAB II PENGORGANISASIAN 3

 2.1 Struktur Organisasi 3

 2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang..... 3

 2.3 Tata Hubungan Kerja..... 5

BAB III TATA LAKSANA..... 6

 3.1 Identifikasi dan Penetapan Pasien Geriatri 6

 3.2 Assesmen Geriatri Komprehensif..... 6

 3.3 Penyusunan Rencana Pelayanan Terpadu..... 6

 3.4 Pelaksanaan Pelayanan Geriatri..... 6

 3.5 Monitoring dan Evaluasi Pasien 7

 3.6 *Discharge Planning*..... 7

 3.7 Rujukan dan Koordinasi lanjutan 7

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 8

 4.1 Monitoring..... 8

 4.2 Evaluasi..... 8

 4.3 Pelaporan 9

BAB V PENUTUP 10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Susunan Tim Terpadu Geriatri..... 3



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR: 001.3/I-PDM/DIR/II/2026**

TENTANG

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN GERIATRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin keselamatan pasien lanjut usia (geriatri), diperlukan pelayanan geriatri yang komprehensif, terpadu, multidisiplin, dan berkesinambungan di rumah sakit;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan geriatri yang efektif, efisien, bermutu, serta sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit dan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi tim pelayanan geriatri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
 7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN GERIATRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;



- (2) Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- (3) Geriatri adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek Kesehatan dan kedokteran pada warga Lanjut Usia termasuk pelayanan Kesehatan kepada Lanjut Usia dengan mengkaji semua aspek Kesehatan berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
- (4) Pasien Geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, social, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan Kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin;
- (5) Tim Terpadu Geriatri adalah suatu tim multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah Kesehatan lanjut usia dengan prinsip tata Kelola pelayanan terpadu dan paripurna dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien lanjut usia.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Pembentukan Tim Pelayanan Geriatri

- (1) Rumah Sakit membentuk Tim Pelayanan Geriatri melalui Surat Keputusan Direktur;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga Kesehatan multidisiplin sesuai kebutuhan;
- (3) Struktur dan keanggotaan Tim Geriatri ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3 Tugas dan Fungsi Tim Pelayanan Geriatri

- (1) Tim Pelayanan Geriatri bertugas menyelenggarakan pelayanan geriatri secara komprehensif dan terintegrasi;
- (2) Tim berfungsi:
 - a. Melakukan Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK);
 - b. Menyusun rencana pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan intervensi sesuai kompetensi;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan;
 - e. Menyusun perencanaan pemulangan pasien (discharge planning).

Pasal 4 Koordinasi dan Tata Hubungan Kerja

- (1) Tim Pelayanan Geriatri bekerja secara kolaboratif dan terkoordinasi dengan seluruh unit pelayanan di rumah sakit;
- (2) Tim wajib melakukan pertemuan berkala untuk membahas kasus dan evaluasi pelayanan;
- (3) Tim bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan.



BAB III TATA LAKSANA

Pasal 5 Pelaksanaan Asesmen Geriatri

- (1) Setiap pasien geriatri wajib dilakukan Asesmen Geriatri Komprehensif sesuai indikasi klinis;
- (2) Asesmen dilakukan secara multidisiplin dan terdokumentasi dalam rekam medis;
- (3) Hasil asesmen menjadi dasar penyusunan rencana pelayanan pasien.

Pasal 6 Pelayanan Geriatri

- (1) Pelayanan geriatri diberikan di seluruh unit pelayanan rumah sakit, meliputi Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, dan unit terkait lainnya;
- (2) Pelayanan geriatri meliputi aspek medis, keperawatan, farmasi, gizi, rehabilitasi, psikososial, serta aspek keselamatan pasien;
- (3) Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi

- (1) Tim Pelayanan Geriatri wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan geriatri secara berkala;
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan

Pasal 8 Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Seluruh kegiatan pelayanan geriatri wajib didokumentasikan dalam rekam medis;
- (2) Tim menyusun laporan kegiatan dan capaian indikator mutu secara berkala;
- (3) Laporan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Rumah Sakit Prima Husada Nomor... tentang Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 01 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 001.3/I-PDM/DIR/I/2026
TENTANG
PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN
GERIATRI

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN GERIATRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan usia harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yang berdampak pada meningkatnya jumlah populasi lanjut usia (geriatri). Seiring dengan bertambahnya usia, pasien geriatri mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan penurunan fungsi organ, penurunan daya tahan tubuh, serta peningkatan risiko terjadinya berbagai penyakit kronis dan degeneratif. Selain itu, pasien geriatri sering mengalami masalah kesehatan yang kompleks, seperti multimorbiditas, penurunan status fungsional, gangguan kognitif, masalah nutrisi, serta masalah psikososial yang memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu.

Pelayanan kesehatan pada pasien geriatri memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, karena memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi melalui suatu tim pelayanan geriatri untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang optimal, efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian pasien.

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan geriatri sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, serta standar akreditasi rumah sakit yang menekankan pelayanan berfokus pada pasien, keselamatan pasien, dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Pelayanan geriatri yang terstruktur dan terkoordinasi melalui tim pelayanan geriatri merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya komplikasi, kecacatan, ketergantungan, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada pasien geriatri.

Selain itu, pembentukan Tim Pelayanan Geriatri juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar profesi, meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kesinambungan pelayanan, serta memastikan bahwa setiap pasien geriatri mendapatkan asesmen geriatri komprehensif dan rencana pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dengan adanya tim pelayanan geriatri yang terorganisir dengan baik, diharapkan pelayanan kepada pasien geriatri dapat dilaksanakan secara optimal, aman, bermutu, dan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri Rumah Sakit sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan geriatri yang terstandar, terintegrasi, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam membentuk, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan pelayanan geriatri melalui tim multidisiplin secara terstruktur, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, guna memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien geriatri, standar pelayanan kesehatan, serta standar akreditasi rumah sakit.

2. Tujuan Umum

Terselenggaranya pelayanan geriatri yang komprehensif, terpadu, bermutu, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien melalui kerja sama tim multidisiplin, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan, mempertahankan kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup pasien geriatri.

3. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pelayanan Geriatri di rumah sakit.
- b. Menjamin terselenggaranya pelayanan pasien geriatri secara multidisiplin, komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- c. Memastikan setiap pasien geriatri mendapatkan Asesmen Geriatri Komprehensif yang meliputi aspek medis, fungsional, mental, nutrisi, dan sosial.
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien geriatri.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien geriatri sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.
- f. Mencegah terjadinya komplikasi, kecacatan, ketergantungan, dan penurunan fungsi pada pasien geriatri.
- g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan melalui perencanaan pelayanan yang tepat dan berkesinambungan.
- h. Mendukung pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
- i. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelayanan geriatri di rumah sakit.

BAB II

PENGORGANISASIAN

2.1 Susunan Tim Terpadu Geriatri

Tabel 2.1.1 Susunan Tim Terpadu Geriatri

Ketua Tim	:	dr. Heriyatmo,Sp. PD
Sekretaris	:	Ns. Isa Ariyanti, S.Kep
Anggota		
1. Dokter Umum	:	dr. Amanda Firmandani dr. Moch. Safri Darmaputra
2. Apoteker	:	Diryati Barin Putri, S. Farm., Apt
3. Perawat	:	1. Ns. Risma Indra Setiyani, S.Kep 2. Billy Mavino Perkasa, Amd.Kep 3. Devi Kartika Sari, Amd.Kep 4. Ns. Saudah, S.Kep 5. Fatimatuzzahro, Amd.Kep 6. Yayuk Rinika, Amd.Kep 7. Ns. Ani Dwi Karima, S.Kep 8. Ns. Dewi Eka Yanti, S.Kep 9. Fifi Wahyuningsih, Amd. Keb 10. Ns. Annisa Fitri, S.Kep 11. Saghita Puspitasari, Amd. Kep
4. Tenaga Gizi	:	Eka Firda Ristia Putri Suryanto, Amd. Gz
5. Fisioterapis	:	Dinar Sahara, Amd. Fis
6. PKRS	:	Mukhammad Eriko Firdaus, S. Kom
7. Rekam Medis Pendaftaran	:	Hury Markustinus, Amd. RMIK., S. MIK

2.2 Uraian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Ketua Tim Pelayanan Getiatri

a. Uraian Tugas

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan geriatri.
- 2) Menetapkan kebijakan teknis pelayanan geriatri bersama manajemen rumah sakit.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK).
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan rencana asuhan pasien geriatri secara multidisiplin.
- 5) Memimpin rapat tim geriatri secara berkala.
- 6) Melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan geriatri.
- 7) Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelayanan pasien geriatri.

b. Tanggung Jawab

- 1) Terlaksananya pelayanan geriatri sesuai standar.
- 2) Terjaminnya keselamatan pasien geriatri.
- 3) Terlaksananya koordinasi tim multidisiplin.
- 4) Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan geriatri

c. Wewenang

- 1) Memberikan arahan kepada anggota tim geriatri.
- 2) Menetapkan rencana pelayanan pasien bersama tim.
- 3) Meminta konsultasi dari tenaga kesehatan lain.

-
- 4) Memberikan rekomendasi kebijakan pelayanan geriatri kepada direktu
 2. Dokter Spesialis/ Dokter Umum
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien geriatri.
 - 2) Menegakkan diagnosis medis.
 - 3) Menyusun rencana terapi medis.
 - 4) Melakukan asesmen medis dalam AGK.
 - 5) Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.
 - 6) Melakukan monitoring perkembangan pasien
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Ketepatan diagnosis dan terapi.
 - 2) Keselamatan pasien selama pelayanan medis.
 - 3) Dokumentasi pelayanan medis di rekam medis
 - c. Wewenang
 - 1) Menetapkan diagnosis medis.
 - 2) Menentukan terapi medis.
 - 3) Meminta pemeriksaan penunjang.
 - 4) Melakukan konsultasi dengan dokter lain
 3. Perawat
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan pengkajian keperawatan geriatri.
 - 2) Mengidentifikasi risiko pasien geriatri (jatuh, dekubitus, delirium, dll).
 - 3) Menyusun rencana asuhan keperawatan.
 - 4) Melaksanakan tindakan keperawatan.
 - 5) Melakukan pemantauan kondisi pasien.
 - 6) Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Terlaksananya asuhan keperawatan yang aman dan bermutu.
 - 2) Ketepatan dokumentasi keperawatan.
 - 3) Keselamatan pasien selama asuhan keperawatan
 - c. Wewenang
 - 1) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai kompetensi.
 - 2) Mengidentifikasi masalah keperawatan.
 - 3) Mengusulkan intervensi kepada tim
 4. Apoteker
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan asesmen penggunaan obat pasien geriatri.
 - 2) Mengidentifikasi potensi interaksi obat.
 - 3) Mengidentifikasi potensi efek samping obat.
 - 4) Memberikan rekomendasi terapi obat kepada dokter.
 - 5) Memberikan edukasi penggunaan obat
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Keamanan penggunaan obat pasien geriatri.
 - 2) Ketepatan pengelolaan obat.
 - 3) Dokumentasi pelayanan farmasi klinik
 - c. Wewenang
 - 1) Melakukan review terapi obat.
 - 2) Memberikan rekomendasi terapi obat.
 - 3) Memberikan edukasi penggunaan obat
 5. Ahli Gizi
 - a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan asesmen status gizi pasien geriatri.

- 2) Menentukan diagnosis gizi.
 - 3) Menyusun rencana intervensi gizi.
 - 4) Memantau status gizi pasien.
 - 5) Memberikan edukasi gizi.
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Ketepatan intervensi gizi.
 - 2) Peningkatan status gizi pasien.
 - 3) Dokumentasi pelayanan gizi
 - c. Wewenang
 - 1) Menentukan intervensi gizi.
 - 2) Memberikan edukasi gizi.
 - 3) Memberikan rekomendasi diet kepada tim
6. Fisioterapis
- a. Uraian Tugas
 - 1) Melakukan asesmen fungsi fisik pasien
 - 2) Menentukan program rehabilitasi.
 - 3) Melaksanakan terapi fisik.
 - 4) Mencegah penurunan fungsi fisik.
 - 5) Melakukan evaluasi hasil terapi
 - b. Tanggung Jawab
 - 1) Peningkatan atau mempertahankan fungsi pasien.
 - 2) Keamanan selama terapi
 - c. Wewenang
 - 1) Menentukan program fisioterapi.
 - 2) Melaksanakan tindakan fisioterapi.

2.3 Tata Hubungan Kerja

- 1. Hubungan dengan Internal Tim Pelayanan Geriatri
 - a. Ketua Tim dengan anggota Tim Geriatri
 - 1) Ketua Tim mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan geriatri.
 - 2) Ketua Tim memberikan arahan kepada seluruh anggota tim.
 - 3) Ketua Tim memimpin diskusi tim dalam penyusunan rencana pelayanan pasien.
 - 4) Anggota tim melaporkan hasil asesmen dan intervensi kepada Ketua Tim.
 - 5) Ketua Tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan geriatri.
 - b. Antar anggota Tim Pelayanan Geriatri
 - 1) Setiap anggota tim melakukan asesmen sesuai bidangnya sebagai bagian dari Asesmen Geriatri Komprehensif (AGK).
 - 2) Anggota tim berkoordinasi dalam penyusunan rencana pelayanan pasien.
 - 3) Setiap profesi memberikan intervensi sesuai kompetensi masing-masing.
 - 4) Anggota tim saling memberikan informasi terkait kondisi pasien.
 - 5) Dilakukan diskusi tim secara berkala
- 2. Hubungan dengan Unit Pelayanan di rumah Sakit
 - a. Instalasi Rawat Jalan
 - 1) Tim geriatri menerima rujukan pasien dari rawat jalan.
 - 2) Tim geriatri memberikan rekomendasi pelayanan lanjutan.
 - 3) Tim geriatri berkoordinasi dalam monitoring pasien
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - 1) Tim geriatri melakukan asesmen dan intervensi pada pasien rawat inap.

-
- 2) Berkoordinasi dengan DPJP dan perawat ruangan.
 - 3) Memberikan rekomendasi pelayanan geriatri.
 - c. Instalasi Gawat Darurat
 - 1) Tim geriatri menerima konsultasi pasien geriatri dari IGD.
 - 2) Memberikan rekomendasi penanganan pasien geriatri.
 - d. Instalasi Farmasi
 - 1) Berkoordinasi dalam penggunaan obat pasien geriatri.
 - 2) Memastikan keamanan terapi obat
 - e. Instalasi Gizi
 - 1) Berkoordinasi dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien
 - f. Instalasi Rehab Medik
 - 1) Berkoordinasi dalam rehabilitasi pasien geriatri
 - g. Instalasi Rekam Medik
 - 1) Mendokumentasikan pelayanan pasien geriatri.
 - 2) Mendukung sistem pencatatan dan pelaporan.
 - 3. Hubungan dengan Manajemen Rumah Sakit
 - a. Direktur Rumah Sakit
 - 1) Tim geriatri bertanggung jawab kepada Direktur.
 - 2) Tim geriatri melaporkan kegiatan secara berkala.
 - 3) Direktur memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya
 - b. Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Mutu
 - 1) Tim geriatri berkoordinasi dalam peningkatan mutu pelayanan.
 - 2) Berpartisipasi dalam program keselamatan pasien
 - 4. Hubungan dengan Pasien dan Keluarga
 - a. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.
 - b. Melibatkan pasien dan keluarga dalam perencanaan pelayanan.
 - c. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami
 - 5. Hubungan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain (Rujukan)
 - a. Berkoordinasi dalam sistem rujukan pasien.
 - b. Menjamin kesinambungan pelayanan pasien

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Identifikasi dan Penetapan Pasien Geriatri

1. Petugas kesehatan mengidentifikasi pasien yang termasuk kategori geriatri, yaitu pasien dengan usia ≥ 60 tahun dan/atau memiliki masalah kesehatan kompleks.
2. Identifikasi dilakukan di seluruh unit pelayanan seperti:
 - a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - b. Rawat Jalan
 - c. Rawat Inap
3. Petugas melakukan skrining awal untuk menentukan kebutuhan pelayanan geriatri.
4. Pasien yang memenuhi kriteria dirujuk kepada Tim Pelayanan Geriatri.

3.2 Asesmen Geriatri Komprehensif

Tim Pelayanan Geriatri melakukan assesmen menyeluruh meliputi:

1. Aspek medis
 - a. Diagnosis penyakit
 - b. Penyakit penyerta (komorbid)
 - c. Penggunaan obat
2. Aspek fungsional
 - a. Kemampuan aktivitas sehari-hari (ADL)
 - b. Mobilitas pasien
3. Aspek kognitif dan mental
 - a. Fungsi kognitif
 - b. Risiko delirium, depresi, demensia
4. Aspek nutrisi
 - a. Status gizi
 - b. Risiko malnutrisi
5. Aspek sosial
 - a. Dukungan keluarga
 - b. Lingkungan pasien
6. Aspek risiko keselamatan pasien
 - a. Risiko jatuh
 - b. Risiko dekubitus
 - c. Risiko komplikasi lainnya

3.3 Penyusunan Rencana Pelayanan Terpadu

1. Tim Pelayanan Geriatri menyusun rencana pelayanan berdasarkan hasil assesmen.
2. Rencana pelayanan meliputi:
 - a. Terapi medis
 - b. Asuhan keperawatan
 - c. Intervensi gizi
 - d. Rehabilitasi medis
 - e. Terapi obat
 - f. Dukungan psikososial
3. Rencana pelayanan didokumentasikan dalam rekam medis.
4. Rencana pelayanan dikomunikasikan kepada seluruh anggota tim

3.4 Pelaksanaan Pelayanan Geriatri

1. Setiap anggota tim melaksanakan intervensi sesuai kompetensi dan rencana pelayanan.

-
2. Pelayanan dilakukan secara multidisiplin.
 3. Dilakukan koordinasi antar anggota tim.
 4. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien

3.5 Monitoring dan Evaluasi Pasien

1. Tim geriatri melakukan pemantauan kondisi pasien secara berkala.
2. Dilakukan evaluasi terhadap:
 - a. Respons terapi
 - b. Perkembangan kondisi pasien
 - c. Risiko komplikasi
3. Dilakukan revisi rencana pelayanan bila diperlukan

3.6 *Discharge Planning* (Perencanaan Pemulangan Pasien)

1. Tim geriatri menyusun rencana pemulangan pasien sejak awal perawatan.
2. Melibatkan pasien dan keluarga dalam perencanaan.
3. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga.
4. Menentukan tindak lanjut pelayanan

3.7 Rujukan dan Koordinasi Lanjutan

1. Pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lain sesuai kebutuhan.
2. Tim geriatri berkoordinasi dengan fasilitas rujukan.
3. Memberikan informasi lengkap mengenai kondisi pasien

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

1. Tujuan Monitoring
 - a. Mengidentifikasi masalah secara dini
 - b. Mencegah komplikasi
 - c. Menjamin pelayanan sesuai standar
2. Monitoring Harian

Dilakukan oleh DPJP dan anggota Tim Geriatri, meliputi:

 - a. Perkembangan kondisi klinis pasien
 - b. Respons terhadap terapi
 - c. Risiko jatuh, dehidrasi, delirium
 - d. Status nutrisi
 - e. Efek samping obat
 - f. Status fungsional pasien
3. Monitoring Berkala Tim

Dilakukan melalui:

 - a. Diskusi kasus multidisiplin
 - b. Rapat tim geriatri mingguan/bulanan
 - c. Evaluasi rencana pelayanan
4. Monitoring Kepatuhan terhadap Prosedur
 - a. Kepatuhan terhadap asesmen geriatri komprehensif (AGK)
 - b. Kepatuhan dokumentasi rekam medis
 - c. Kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien

4.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada dua tingkat, yaitu evaluasi klinis dan evaluasi program

1. Evaluasi Klinis Pasien
 - a. Dilakukan terhadap
 - 1) Perbaikan kondisi medis
 - 2) Perubahan status fungsional
 - 3) Perbaikan status nutrisi
 - 4) Stabilitas kondisi psikologis
 - 5) Tingkat kemandirian pasien
 - b. Bila hasil tidak optimal
 - 1) Dilakukan revisi rencana pelayanan
 - 2) Dilakukan konsultasi tambahan
 - 3) Dilakukan intervensi lanjutan
2. Evaluasi Program Pelayanan Geriatri
 - a. Tujuan:
 - 1) Menilai efektivitas pelayanan
 - 2) Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
 - 3) Mendukung program peningkatan mutu (PMKP)
 - b. Audit internal

Meliputi:

 - 1) Audit rekam medis pasien geriatri
 - 2) Audit penggunaan obat (polypharmacy)
 - 3) Audit discharge planning
 - c. Evaluasi sumber daya
 - 1) Ketersediaan SDM
 - 2) Ketersediaan sarana dan prasarana
 - 3) Kebutuhan pelatihan

4.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan geriatri kepada manajemen rumah sakit.

1. Laporan kegiatan Tim Geriatri

Disusun secara berkala (bulanan/triwulan/tahunan), meliputi:

- a. Jumlah pasien geriatri yang dilayani
- b. Jenis kasus terbanyak
- c. Hasil monitoring dan evaluasi
- d. Capaian indikator mutu
- e. Permasalahan dan tindak lanjut

2. Pelaporan kepada Direktur

Disampaikan oleh Ketua Tim Geriatri

- a. Laporan kinerja tim
- b. Rekomendasi perbaikan pelayanan
- c. Kebutuhan pengembangan layanan

BAB V

PENUTUP

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri Rumah Sakit ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri yang komprehensif, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan, dengan melibatkan tim multidisiplin sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya masing-masing. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung terselenggaranya pelayanan yang bermutu, efektif, efisien, serta berorientasi pada keselamatan pasien geriatri.

Dengan adanya pedoman ini, seluruh anggota Tim Pelayanan Geriatri dan unit terkait di rumah sakit diharapkan dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional, terintegrasi, serta sesuai dengan standar pelayanan, standar akreditasi rumah sakit, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta peningkatan mutu pelayanan geriatri secara berkelanjutan.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan dilakukan evaluasi serta peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pelayanan, serta perubahan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pelayanan geriatri di rumah sakit dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas hidup pasien geriatri, serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang paripurna dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Demikian Pedoman Kerja Tim Pelayanan Geriatri Rumah Sakit ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Januari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes